

Regulacja *wartości*

Samoocena w NPD jest wysoka, ale niestabilna (Zeigler-Hill 2006). Cel: budowa wewnętrznego systemu — niezależnego od podziwu, sukcesu i kontroli.

CZAS: 15 min Plan terapeutyczny **ŹRÓDŁO:** Kernis (2003); Neff (2003); Zeigler-Hill (2006)

JAK UŻYWAĆ

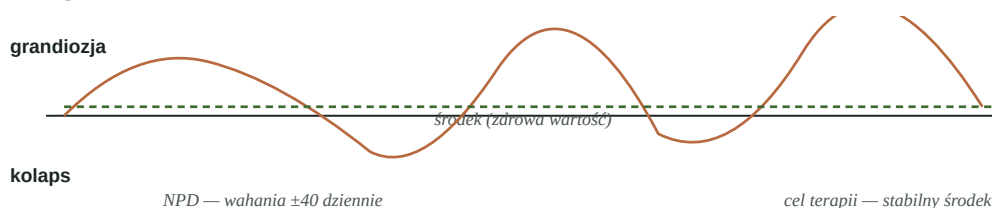
1 · Zrozumiesz *contingent self-esteem* (sekcja 01) — dlaczego samoocena w NPD oscyluje między grandiozją a kolapsem. **2** · Poznasz *trzy filary* stabilizacji wartości (sekcja 02). **3** · Wykonasz **realistyczną mapę mocnych stron i ograniczeń** z feedbackiem od pięciu osób (sekcja 03). **4** · Zmierzysz się z *tolerancją zwyczajności* — najtrudniejszym ćwiczeniem w NPD (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Regulacja samooceny w NPD jest **w pełni zewnętrzna** — pacjent „dostraja” wartość moment po moment do reakcji otoczenia, co generuje skrajną labilność. Crocker & Wolfe (2001) opisali to jako *contingent self-esteem* (warunkowa samoocena): wartość zależna od zewnętrznych warunków. Kernis (2003) pokazał, że **niestabilna wysoka samoocena** jest predyktorem agresji, depresji i destrukcyjnych zachowań — silniejszym niż sama niska samoocena. Zeigler-Hill (2006) udowodnił, że samoocena w NPD jest *wysoka, ale niestabilna* — nie po prostu „wysoka”. Oscylacja: **grandiozja** (po sukcesie, podziwie) ↔ **załamanie** (po krytyce, porażce). Cel terapii: zbudowanie *wewnętrznego, stabilnego* poczucia wartości niezależnego od osiągnięć i podziwu. Narzędzia: (1) CFT (Gilbert): *wartość inherentna* — „jesteś wartościowy, bo jesteś, nie bo osiągasz”; (2) ACT (Hayes): praca z *wartościami* ważniejszymi niż osiągnięcia; (3) terapia schematów (Young): leczenie trybu *Vulnerable Child*. Neff (2003) wykazała, że *self-compassion* jest **silniejszym predyktorem dobrostanu niż sama samoocena** — i nie generuje narcystycznej kompensacji (metaanalizy: $d \approx 0,7$ dla efektu na samoocenę). Mechanizm: *self-compassion* daje *bezwarunkowe* źródło wartości („jestem życzliwy/-a wobec siebie niezależnie od wyniku”). Aktywuje system uspokajania (nerw błędny, oksytocyna), wyłącza system zagrożenia. Z biegiem czasu — internalizuje się. **Bariera kliniczna:** w NPD *self-compassion* budzi *opór* („to słabość, dla loserów”). Trzeba pracować z trybem *Punitive Parent* Younga, który *zabrania* życzliwości wobec siebie. Bez rozbrojenia tego trybu narzędzia się nie zakorzeniają.

01

📄 Contingent self-esteem — labilność wartości



Wahania w NPD są ekstremalne: rano sukces → euforia („jestem niesamowity/-a”) → wieczorem krytyka → załamanie („jestem nikim”). Każda emocja jest „11 na skali 10”. Bez wewnętrznej regulacji — **każda** krytyka jest egzystencjalnym zagrożeniem. Skrajna labilność wyczerpuje pacjenta i otoczenie.

02 Trzy filary stabilizacji wartości

1 · REALISTYCZNY OBRAZ

Lista mocnych stron i **ograniczeń**, opierająca się na *feedbacku* od 5 osób, nie tylko wewnętrznej narracji. „Mam talent do X, słabość w Y — i to jest OK.”

2 · SELF-COMPASSION

Neff (2003): życzliwość, wspólne człowieczeństwo, uważność. „Jestem życzliwy/-a wobec siebie *niezależnie* od dzisiejszej oceny.” $d \approx 0,7$ dla wpływu na samoocenę.

3 · ODDZIELENIE WARTOŚCI OD WYNIKU

ACT (Hayes): „Kim chcę być” > „Co chcę osiągnąć”. Wartości jako kompas, niezależnie od dzisiejszego rezultatu. Cenny *niezależnie* od oceny.

03 Mapa mocnych stron i ograniczeń — z feedbackiem 5 osób

Zapytaj *pięć* osób z różnych obszarów Twojego życia (partner, kolega z pracy, przyjaciel, członek rodziny, terapeuta): „Co według Ciebie jest moją mocną stroną? Co jest moim ograniczeniem?” Zapisuj **dosłownie**, bez dyskusji. Cel: zderzenie wewnętrznej narracji z zewnętrznym lustrem.

OSOBA	MOJA MOCNA STRONA — wg niej/niego	MOJE OGRANICZENIE — wg niej/niego

04 Tolerancja zwyczajności — najtrudniejsze ćwiczenie

CO JEST TRUDNE

„Bycie przeciętnym/-ą w czymś = bycie *nikim*.”
Pacjent z NPD **nie** rozróżnia tych dwóch. Stąd unikanie obszarów, w których nie błyszczy.

EKSPERYMENT

Wybierz *jeden* obszar, w którym jesteś przeciętny/-a, i utrzymaj go przez miesiąc *bez* próby wyróżnienia się. Sport amatorski, hobby dla przyjemności. *Wytrzymaj zwyczajność.*

Klucz: regulacja wartości w NPD wymaga *przebudowy systemu*, nie samej korekty pojedynczych myśli. **Bez wewnętrznego źródła wartości** pacjent zawsze będzie zależny od zewnętrznych sygnałów — a te są niestabilne. Self-compassion (Neff 2003, $d \approx 0,7$) jest *silniejszym* predyktorem dobrostanu niż sama samoocena — i nie generuje narcystycznej kompensacji. Ale w NPD budzi opór („to słabość”), więc wymaga pracy z trybem *Punitive Parent* Younga, który zabrania życzliwości wobec siebie. **Tolerancja zwyczajności** jest najtrudniejszym ćwiczeniem — pacjent musi nauczyć się, że bycie „wystarczającym” nie jest tym samym, co bycie „bezwartościowym”. To jeden z głównych celów wieloletniej terapii (2–5 lat).